Algoritmo de la fibrilación auricular en Urgencias

Hospital de Campdevànol · Manejo completo · Punto de corte para cardiovertir: **24 horas** · Guía **ESC 2024**

Original: Dra. Claudia Abad (Urgencias)
Versión 2.0 revisada según ESC 2024 · noviembre 2026

0 ¿FA PREEXCITADA?

QRS ancho, de morfología cambiante, muy irregular, a menudo FC > 250 lpm; onda delta en ECG previos.

SÍ → NO betabloqueante, verapamilo, diltiazem, digoxina, adenosina ni amiodarona IV (aceleran la vía accesoria → FV). **Cardioversión eléctrica**; si estable, alternativa: procainamida o flecainida IV. Avisar a cardiología.

1 ¿INESTABILIDAD HEMODINÁMICA?

Hipotensión · shock · EAP · síncope · isquemia en curso, **atribuibles a la FA**.

SÍ → CVE urgente: 200 J bifásicos sincronizada, con sedación (ver hoja de sedación). **No esperar** a la anticoagulación ni a la duración: **heparina en cuanto sea posible**, sin retrasar la descarga. Monitorización continua.

2 CONTROL DE FRECUENCIA (estable) · objetivo inicial FC < 110 lpm · tratar el desencadenante

FEVI > 40 %
Metoprolol 2,5–5 mg IV en 2 min; repetir cada 5 min (máx. 15 mg).
Verapamilo 2,5–10 mg IV en 5 min (el diltiazem IV no está comercializado en España).
No juntar betabloqueante IV y verapamilo IV sin monitorización estrecha.

FEVI ≤ 40 % · insuficiencia cardiaca · TAS límite
Evitar verapamilo y diltiazem.
Betabloqueante a dosis bajas (metoprolol 2,5 mg IV) si no hay IC descompensada ni hipotensión.
Digoxina 0,5 mg IV lenta, después 0,25 mg cada 6 h (máx. 1,5 mg/24 h; reducir en insuficiencia renal).
Amiodarona si inestable o refractaria (puede revertir la FA).

Si no se controla
Revisar la causa: sepsis, hipovolemia, anemia, hipoxemia, TEP, tirotoxicosis, iones.
Combinar betabloqueante o verapamilo + digoxina; amiodarona IV si no basta.
Si aparece inestabilidad → CVE. Consultar con cardiología.

¿DURACIÓN DEL EPISODIO? — PUNTO DE CORTE: 24 HORAS (ESC 2024; antes 48 h) · Si la duración es desconocida → tratar como > 24 h · la ACC/AHA 2023 mantiene 48 h

FA < 24 h de inicio seguro — riesgo tromboembólico bajo

3 ANTICOAGULAR ANTES DE CARDIOVERTIR

ACOD (dosis única antes de la CV, después continuar):
• **Apixabán 10 mg VO** (**5 mg** si ≥ 2 de: ≥ 80 años, ≤ 60 kg, creatinina ≥ 1,5 mg/dl); **cardiovertir ≥ 2 h después**. Continuar 5 mg/12 h; FG 15–29: 2,5 mg/12 h; FG < 15: no.
• **Rivaroxabán 20 mg VO** con comida. FG 15–49: 15 mg/24 h; FG < 15: no.
• **Dabigatrán 150 mg VO**, después 150 mg/12 h (110 mg/12 h si ≥ 80 años o verapamilo). FG < 30: contraindicado.
Heparina (urgencia o FG < 30): HNF bolo 60–80 UI/kg IV (máx. 5.000) + 12–18 UI/kg/h, TTPa 1,5–2,5 veces el control (60–100 s), control a las 4–6 h; sin ajuste por FG. O enoxaparina 1 mg/kg/12 h SC (FG 15–29: 1 mg/kg/24 h).

4 ¿CARDIOVERTIR YA O ESPERAR?

Opción ESC 2024: **esperar y ver** hasta 48 h con control de frecuencia y anticoagulación: el 69 % revierte solo y no fue inferior a la CV precoz (RACE 7). Si no revierte → CV.

¿Cardiopatía estructural?
IC o FEVI reducida · hipertrofia ventricular grave · valvulopatía significativa · cardiopatía isquémica.

NO → cardioversión farmacológica

Frenar antes el nodo AV (evita el flutter 1:1): bisoprolol 2,5–5 mg VO 30–60 min antes de la flecainida/propafenona VO; con la IV, asociar un frenador. Si ya toma betabloqueante: dar directamente.
• **Flecainida** 2 mg/kg IV en 10 min (**máx. 150 mg**) o 200–300 mg VO. Parar si el QRS se ensancha > 25 %. No con Brugada ni ClCr < 35.
• **Propafenona** 450–600 mg VO dosis única.
• **Vernakalant** 3 mg/kg IV en 10 min (máx. 339 mg); si no revierte en 15 min, **2 mg/kg** en 10 min (máx. 226 mg). No con TAS < 100, SCA < 30 días, NYHA III–IV, QT largo ni estenosis aórtica grave.
• O **CVE** 200 J bifásicos sincronizada.

SÍ → amiodarona o CVE

• **Amiodarona 300 mg IV en 30–60 min** (≈ 5 mg/kg), después **900–1.200 mg en 24 h** (≈ 50 mg/h). Revierte en horas.
• Vía venosa gruesa y diluida; mejor **vía central** si la perfusión es larga (flebitis).
• O **CVE** 200 J bifásicos sincronizada, con sedación.
• **No flecainida ni propafenona.**

5 ANTICOAGULACIÓN TRAS LA CARDIOVERSIÓN · ≥ 4 semanas

Opcional solo si el inicio era seguro < 24 h y CHA_2DS_2-VA = 0. Después, indefinida según CHA_2DS_2-VA. Pauta local: observación 4 h monitorizado y ECG de control tras la CV.

FA > 24 h o de duración desconocida — riesgo tromboembólico ALTO

3 ANTICOAGULAR DE INMEDIATO (no demorar)

ACOD a dosis de FA (sin dosis de carga):
• **Apixabán 5 mg/12 h**; 2,5 mg/12 h si ≥ 2 de: ≥ 80 años, ≤ 60 kg, creatinina ≥ 1,5; FG 15–29: 2,5 mg/12 h; FG < 15: no. **No usar 10 mg/12 h × 7 días: es la pauta de la trombosis venosa.**
• **Rivaroxabán 20 mg/24 h** con la cena; FG 15–49: 15 mg/24 h; FG < 15: no.
• **Dabigatrán 150 mg/12 h**; 110 mg/12 h si ≥ 80 años o verapamilo; con FG 30–50 bajar a 110 solo si el riesgo hemorrágico es alto. FG < 30: contraindicado.
Acenocumarol (INR 2–3): solo con prótesis mecánica o estenosis mitral moderada-grave.
Heparina si FG < 30 o ingreso: HNF IV (pauta de la columna izquierda) o HBPM con anti-Xa.

Vía A — CV diferida

Anticoagulación eficaz **≥ 3 semanas** → CV electiva (programar con cardiología).

Vía B — CV precoz guiada por ETE

Con la anticoagulación **ya iniciada**: la ETE descarta trombo en la orejuela → CV. Si hay trombo: anticoagular ≥ 3 semanas y repetir la ETE.

Mientras tanto

Control de frecuencia. **Evitar los fármacos que pueden revertir la FA** (amiodarona, flecainida) salvo que no haya alternativa.

SIN cardiopatía → CV farmacológica o eléctrica

Mismos fármacos y precauciones que en la FA < 24 h (frenar el nodo AV antes; flecainida máx. 150 mg; vernakalant con sus contraindicaciones), o CVE 200 J bifásicos sincronizada.

CON cardiopatía → amiodarona o CVE

Amiodarona 300 mg IV en 30–60 min, después 900–1.200 mg en 24 h; o CVE 200 J bifásicos sincronizada si no responde al fármaco.

4 ANTICOAGULACIÓN TRAS LA CARDIOVERSIÓN · SIEMPRE ≥ 4 semanas

Después, indefinida según CHA_2DS_2-VA. **No suspender sin valoración.** Pauta local: observación 4 h y ECG de control tras recuperar el ritmo sinusal.

CHA_2DS_2-VA (ESC 2024)

C · Insuficiencia cardiaca	1	S_2 · Ictus / AIT / embolia previa	2
H · Hipertensión	1	V · Enfermedad vascular	1
A_2 · Edad ≥ 75 años	2	A · Edad 65–74 años	1
D · Diabetes	1	El sexo femenino ya no suma (máx. 8)	

≥ 2 → anticoagulación recomendada · 1 → considerarla · 0 → no. La ACC/AHA 2023 sigue usando CHA_2DS_2-VASc.

PLAN AL ALTA Y SEGUIMIENTO

Amiodarona oral (pauta local; descontar lo recibido IV): 200 mg/8 h la 1.ª semana · 200 mg/12 h la 2.ª · después 200 mg/día.
Control del ritmo crónico: betabloqueante VO, flecainida VO (sin cardiopatía estructural) o amiodarona VO.
Anticoagulación según CHA_2DS_2-VA. Derivar a cardiología; valorar ablación si la FA recurre.

CONTRAINDICACIONES CLAVE

FA preexcitada: nada que frene el nodo AV ni amiodarona IV.
Flecainida / propafenona: no con cardiopatía estructural, isquémica o IC; siempre con frenador del nodo AV.
Verapamilo / diltiazem: no si FEVI ≤ 40 %, IC descompensada o hipotensión. El betabloqueante sí puede usarse con prudencia.
CVE: siempre sincronizada, con sedación y monitorización continua.

Siglas: ACOD, anticoagulante oral de acción directa; CV/CVE, cardioversión / cardioversión eléctrica; ETE, ecocardiografía transesofágica; FG, filtrado glomerular (ml/min); HNF, heparina no fraccionada; HBPM, heparina de bajo peso molecular; IC, insuficiencia cardiaca; SCA, síndrome coronario agudo.

Fuentes: ESC 2024 de FA (Van Gelder, PMID 39210723, tablas 12 y 13); EHRA 2018 de ACOD (PMID 29562325); EMANATE (PMID 29659797); RACE 7 ACWAS (PMID 30883054); ACC/AHA 2023 (PMID 38033089). Uso clínico orientativo: adaptar a cada paciente. **Pendiente de validación por la autora.**